



ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz)

ALS, beyin ve omurilikteki motor nöron adı verilen sinir hücrelerinin zamanla hastalanıp ölmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hücreler kaslara hareket emri verir. Onlar bozulunca kaslar güçsüzleşir, erir ve istemli hareketler (yürüme, konuşma, yutma, nefes alma gibi.) zorlaşır. Hastalık ilerleyicidir. Duyular, bağırsak-mesane kontrolü, kalp kası ve genellikle zeka etkilenmez göz kasları ise en son ya da neredeyse hiç bozulmayabilir.

Dünyada her yıl 100 bin kişide yaklaşık 2-6 yeni vaka görülür. Avrupa’da yaygınlık 100 binde 10-12 civarındadır. En sık 45-75 yaş arasında, ortalama 55-65 yaşlarında başlar. Erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülür; ileri yaşlarda oranlar eşitlenir. Vakaların yüzde 90-95’i rastgele (sporadik), yüzde 5-10’u ailevi/genetiktir. Yaşam boyu risk erkeklerde yaklaşık 1/350, kadınlarda 1/400’dür.

İlk belirtiler çoğu zaman hafif ve tek taraflıdır: Elde başparmak güçsüzlüğü ve kas erimesi, bacakta düşük ayak (yürürken takılma), konuşma veya yutma güçlüğü. kas seğirmesi, kramp, sertlik ve halsizlik sık görülür. Hastalar bunları “çok çalıştım” veya “sinir sıkışması” sanabilir. Belirtiler yavaş yavaş diğer bölgelere yayılır. Hastaların yaklaşık üçte birinde hastalık konuşma-yutma kaslarından başlar; bu form daha hızlı ilerleyebilir. Yaklaşık yarısında hafif bilişsel veya davranış değişiklikleri olabilir, yüzde 10-15’inde frontotemporal demans eşlik eder. İlerleyen dönemde yürüme, konuşma, yutma ve nefes alma bozulur; hasta yatağa bağımlı hale gelebilir ve solunum cihazına ihtiyaç duyabilir.

Kesin neden bilinmemektedir. Yüzde 10 kadarında genetik faktörler rol oynar; en sık C9orf72 genindeki tekrar genişlemesi, SOD1, TARDBP ve FUS mutasyonları görülür. Sporadik vakalarda yaş, erkek cinsiyet, sigara, yüksek fiziksel aktivite, kafa travması, kimyasal maddeler, ağır metaller ve bazı enfeksiyonlar risk artırıcı olarak düşünülür ama kesin ilişki kanıtlanmamıştır.

Motor korteks, beyin sapı ve omurilik ön boynuzundaki üst ve alt motor nöronlar kaybolur. Hastaların yüzde 95’inden fazlasında TDP-43 adlı protein hücre içinde birikir. Protein bozulması, RNA metabolizması, hücre iskeleti ve aksonal taşıma bozuklukları gibi birçok yol hastalıkta rol oynar.

Tek bir test yoktur. Nörolojik muayene, EMG (sinir ve kas elektrik aktivitesi) ve hastalık taklit eden durumları (sinir sıkışması, fitik, kas hastalıkları, bazı kanserler) dışlayan kan, MR, lomber ponksiyon gibi incelemelerle tanı konur. Erken dönemde karışabilir, bu yüzden dikkatli değerlendirme önemlidir.

Kesin tedavisi yoktur. Riluzol hastanın hayatta kalma ömrünü ortalama 3-6 ay uzatabilir. Bazı ülkelerde edaravone ve SOD1 mutasyonu olanlarda tofersen kullanılır. Temel yaklaşım çok disiplinli bakımdır: Fizik tedavi, konuşma ve yutma terapisi, solunum desteği (noninvaziv

ventilasyon) ve semptom giderici ilaçlar. İyi bakım, düzenli kontrol ve hasta-hekim iletişimi yaşam kalitesini ve süresini belirgin şekilde etkiler.

Tanıdan sonra ortalama yaşam süresi 2-5 yıldır; yüzde 5-10 hasta 10 yıl ve daha uzun yaşar. Ölüm çoğu zaman solunum yetmezliğinden olur. Hareketsizlik, yetersiz beslenme ve solunum sorunları ek hastalık riskini artırır. İyi bakım ve destek ise bu süreci uzatabilir.

Genetik alt tiplere yönelik antisense oligonükleotid tedavileri ve kök hücre çalışmaları devam etmektedir. Biyobelirteç araştırmaları ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar umut vermektedir. Multidisipliner bakımın önemi giderek daha çok vurgulanmaktadır.

Toparlarsak ALS, beyin ve omurilikteki motor nöronların ilerleyici kaybıyla kasların güçsüzleşip erimesine yol açan, henüz kesin tedavisi olmayan bir hastalıktır. Genellikle 50’li yaşlarda, erkeklerde biraz daha sık görülür; belirtiler çoğu zaman elde veya bacakta hafif güçsüzlükle başlar ve yavaş yavaş tüm vücuda yayılır. Nedeni büyük ölçüde bilinmez, yüzde 10’unda genetik faktörler rol oynar. Tanı klinik bulgular ve EMG ile konur, tedavi destekleyici bakıma dayanır. Ortalama yaşam süresi 2-5 yıl olmakla birlikte iyi bakımla bu süre uzayabilir.

Kaynaklar:

1) Yeditepe University Hospitals Medical Publication Board. (2021,



April 8; updated 2026, April 17). The first symptoms of ALS are mistaken for nerve compression. Yeditepe University Hospitals.

<https://yeditepehastaneleri.com/saglik-rehberi/hastaliklar-tedaviler/alsnin-ilk-belirtileri-sinir-sikismasi-saniliyor>

2) Acıbadem Medical Publication Board. (2026, March 24). What is ALS Disease? ALS Symptoms, Causes and Treatment. Acıbadem.

<https://www.acibadem.com.tr/hastaliklar-ve-belirtiler/als-amyotrofik-lateral-skleroz/>

3) Masrori P, Van Damme P. Amyotrophic lateral sclerosis: a clinical review. Eur J Neurol. 2020 Oct;27(10):1918-1929. doi: 10.1111/ene.14393. Epub 2020 Jul 7. PMID: 32526057; PMCID: PMC7540334.

4) National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). National Institutes of Health.

<https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als>

Yayın Tarihi: 6 Eylül 2026

Sorumlu Yazar: Ali Bocakkıtay/ Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi